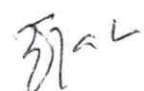
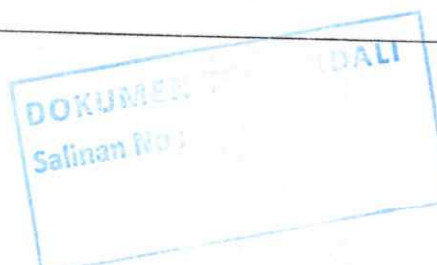


INSTRUKSI KERJA PENGAMBILAN DARAH KONVENSIONAL

NO DOKUMEN	:	UDDP-PDD-L3-007
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	21 NOVEMBER 2022
TANGGAL KAJI ULANG	:	21 NOVEMBER 2024
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : ☐ SALINAN NO : ☒

Disusun oleh: Iftitah Uli Azmi, A.Md.Kes Staff Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 10.11.2022
Diperiksa oleh : dr. Idah Wido Sari N Kasie. Sub. Bidang Penyediaan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 11.11.2022
Disetujui oleh : dr. Nova Surya Indah Hippy, M,Biomedik Kepala Bidang Pelayanan Darah UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 15.11.2022
Disahkan oleh: Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomedik Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 17.11.2022



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	INSTRUKSI KERJA PENGAMBILAN DARAH		Halaman 1 dari 3 Nomor : UDDP-PDD-L3-007 Versi : 001 Tgl. berlaku : 21-11-2022 Tgl. kaji ulang : 21-11-2024
	Sub. Bidang Penyediaan Darah	Bidang Pelayanan Darah	

1. Tujuan

Instruksi kerja ini sebagai petunjuk untuk menjamin pengambilan darah lengkap dari pendonor untuk memenuhi kebutuhan transfusi bagi penyembuhan penyakit atau pemeliharaan kesehatan sesuai standar maupun penelitian.

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas teknis pengambilan darah

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Hanya dilakukan terhadap calon pendonor yang lulus seleksi dan telah menandatangani formulir informed consent.
- 3.2 Proses pengambilan darah dilakukan dalam sistem tertutup untuk menghindari kontaminasi sehingga didapatkan darah yang aman bagi pasien.
- 3.3 Dilakukan oleh petugas yang berkompeten dengan menerapkan kewaspadaan universal
- 3.4 Dilakukan dengan menggunakan peralatan pengambilan darah yang telah dikualifikasi dan bahan habis pakai yang telah divalidasi.
- 3.5 Proses mengacu pada prosedur yang telah divalidasi.
- 3.6 Bahan kritikal sesuai standar

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PerKa No 10 tahun 2018 Pedoman CPOB untuk unit penyedia darah

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 Definisi
 - 5.1.1 Petugas Teknik Pengambilan Darah adalah petugas yang sudah terlatih melakukan pengambilan darah
- 5.2 Singkatan
 - 5.2.1 IK : Instruksi Kerja
 - 5.2.2 PerKa : Peraturan Kepala
 - 5.2.3 CPOB : Cara Pembuatan Obat Benar

6. Peralatan dan Bahan

- 6.1 Peralatan Pengambilan Darah Konvensional
 - 6.1.1 Hemoscale
 - 6.1.2 Tensimeter

DOCUMENT TERKENDALI

Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA PENGAMBILAN DARAH

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 1 dari 3

Nomor : UDDP-PDD-L3-007

Versi : 001

Tgl. berlaku : 21-11-2022

Tgl. kaji ulang : 21-11-2024

- 6.1.3 Stripper
- 6.1.4 Pinset
- 6.1.5 Pean
- 6.1.6 Gunting steril
- 6.1.7 Bantalan tangan
- 6.1.8 Rak Tabung
- 6.1.9 Tempat kapas
- 6.1.10 Tempat pinset
- 6.1.11 Tempat limbah infeksius
- 6.1.12 Tempat limbah non infeksius

6.2 Bahan

- 6.2.1 Kantong Darah
- 6.2.2 Sarung Tangan
- 6.2.3 Label
- 6.2.4 Lembar Kerja (form barcode)
- 6.2.5 Kassa steril
- 6.2.6 Micropore
- 6.2.7 Plester
- 6.2.8 Tabung EDTA
- 6.2.9 Alkohol swab
- 6.2.10 Povidone iodine 10%

7. Instruksi Kerja

- 7.1 Lakukan verifikasi data donor dengan konfirmasi data secara aktif
- 7.2 Siapkan kantong darah, lakukan verifikasi kantong yang mencakup masa kedaluwarsa, kondisi selang, kebocoran, warna anti koagulan, kesesuaian nomor selang dengan label barcode
- 7.3 Tempatkan tangan donor lurus di samping dengan posisi menghadap keatas.
- 7.4 Pasang manset tensimeter pada 3 jari di atas fossa cubiti dengan posisi selang/pipa tensimeter diatas.
- 7.5 Naikkan tensimeter sampai batas antara sistolik dengan diastolik, raba dan tentukan letak vena dimana akan dilakukan penusukan, turunkan tensimeter.
- 7.6 Teteskan larutan povidone iodine 10%, pada lengan yang akan ditusuk. Ambil kapas, dengan menggunakan pinset lakukan desinfeksi lengan, dari satu titik di tengah dengan gerakan melingkar dari arah dalam keluar 1 kali. Hindari arah berlawanan karena dapat membawa kotoran ke lokasi penusukan vena. Ambil alkohol swab, lakukan desinfeksi vena dengan cara yang sama sebanyak 2 kali.
- 7.7 Buatlah simpul longgar pada selang kantong darah $\pm$ 15 cm dari arah jarum.
- 7.8 Tempatkan kantong darah di atas Hemoscale yang sudah di set dengan posisi label menghadap ke bawah.
- 7.9 Naikkan tensimeter 40 – 60 mmHg untuk melakukan penusukan.
- 7.10 Lakukan penusukan vena dengan cara :

Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA PENGAMBILAN DARAH

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 1 dari 3

Nomor : UDDP-PDD-L3-007

Versi : 001

Tgl. berlaku : 21-11-2022

Tgl. kaji ulang : 21-11-2024

- Buka tutup jarum, posisi lubang jarum menghadap ke atas
 - Tekan secara pelan lengan donor di bawah lokasi penusukan dengan tangan kiri
 - Tusukan jarum 1 atau 2 cm dari vena, dorong sampai berada di tengah vena
JANGAN SAMPAI MENEMBUS SISI VENA YANG LAIN. BISA TERJADI HEMATOMA PADA LENGAN DONOR
 - Aturlah posisi jarum searah dengan vena setelah darah keluar
 - Turunkan tensimeter antara 20 mmHg – 40 mmHg
 - Lakukan fiksasi selang dilengan donor dengan menggunakan meditate di 2 (dua) tempat agar kedudukan jarum tidak berubah (bonggol jarum dan selang kantong di bawahnya)
 - Tutup tempat penusukan lengan donor dengan kassa steril
 - Catat waktu jam penusukan
- 7.11 Apabila volume darah sudah tercapai sesuai dengan jenis kantong darah yang dipakai, jepitlah selang dengan klem A $\pm$ 5 cm dari arah jarum.
- 7.12 Serut selang kantong dari klem A ke arah kantong darah dengan menggunakan *stripper* sepanjang $\pm$ 5cm, kemudian jepit selang kantong darah dengan klem B $\pm$ 2cm dari klem.
- 7.13 Potong selang kantong darah di antara klem A dengan klem B, pilih selang yang paling bersih dari darah donor kemudian kencangkan simpul pada selang.
- 7.14 Tempatkan tabung sampel di ujung potongan selang, buka klem A dan isilah tabung sampel tersebut dengan darah vena donor dengan cara tabung dimiringkan, sehingga darah mengalir melalui dinding tabung EDTA sebanyak $\pm$ 3 ml langsung dari selang yang masih ada di tangan donor tersebut.
- 7.15 Tutup klem A.
- 7.16 Turunkan tensimeter sampai batas nol, buang kassa steril ke tempat limbah infeksius.
- 7.17 Ambil kapas yang diberi alkohol 70 % atau kassa steril kering letakkan di atas tusukan vena dengan sedikit ditekan, kemudian cabutlah jarum dari lengan donor secara perlahan
- 7.18 Minta donor menekan bekas tusukan pada vena dengan kapas yang diberi alkohol 70 % tadi, lepas tensi meter dan minta donor untuk mengangkat tangan ke atas.
- 7.19 Buang jarum ke dalam tempat limbah tajam infeksius.
- 7.20 Serut selang kantong darah dengan menggunakan *stripper* ke arah kantong darah hingga darah masuk kedalam kantong darah, homogenkan perlahan agar tercampur sempurna, lepaskan *stripper* hingga selang darah dapat terisi kembali dengan darah yang telah tercampur antikoagulan ulangi sebanyak 2 kali, rapikan selang.
- 7.21 Cocokkan nomor sampel dengan nomor kantong, nomor tabung sampel dengan formulir barcode dan formulir kuisioner dan *informed consent*.
- 7.22 Catat waktu pengambilan dengan melihat waktu pengambilan di hemoscale atau stop watch jika hemoscale tidak terdapat durasi waktu pengambilan darah.
- 7.23 Simpan darah dalam blood bank refrigerator pada suhu $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ atau biarkan di suhu kamar bila darah tersebut diperuntukkan untuk komponen Trombosit.
- 7.24 Rawat luka tusukan pada vena donor, bila tidak ada perdarahan tutup dengan plester, amati $\pm$ 5 menit

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :



Palang
Merah
Indonesia

Unit Donor Darah Pusat

INSTRUKSI KERJA PENGAMBILAN DARAH

Sub. Bidang
Penyediaan Darah

Bidang
Pelayanan Darah

Halaman 1 dari 3
Nomor : UDDP-PDD-L3-007
Versi : 001
Tgl. berlaku : 21-11-2022
Tgl. kaji ulang : 21-11-2024

- 7.25 Persilahkan donor ke ruang istirahat pendonor bila tidak ada keluhan dari donor dengan lengan donor tetap posisi di atas letak jantung.
- 7.26 Pengambilan darah tidak melebihi 12 menit jika darah akan dijadikan komponen trombosit dan fresh frozen plasma.
- 7.27 Durasi pengambilan darah (kurang dari 12 menit, 12-15 menit, lebih dari 15 menit ditulis pada stiker karantina.
- 7.28 Diawasi selama dan pasca pengambilan darah untuk melihat adanya reaksi samping pengambilan darah
- 7.29 Dilakukan pencatatan dan pelaporan proses pengambilan darah dan reaksi samping yang terjadi.

8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Kesimpulan
001	21 - 11 - 2022	PMK dan CPOB	Dokumen Baru

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No :